

HealthMatch

Business Plan

Plataforma de gestão e alocação inteligente de força de trabalho em saúde

Versão	Captação Pre-seed
Data	Junho / 2026
Estágio	Pré-lançamento — produto funcionalmente pronto
Beachhead	Fortaleza / Ceará
Modelo	Híbrido: SaaS (MRR) + fee de intermediação (take-rate)
Captação-alvo	R\$ 1,5 milhão (pre-seed)

Documento confidencial. Em pré-lançamento, sem receita realizada: todas as projeções são premissas de mercado, sinalizadas com , baseadas em benchmarks de SaaS/marketplace no Brasil (2024–2025) e a validar no piloto com a cooperativa-âncora.

Sumário

1. Sumário executivo.....	3
2. Descrição da plataforma.....	4
3. Análise de mercado.....	5
4. Público-alvo e personas.....	7
5. Produto e funcionalidades.....	8
6. Estratégia de marketing e vendas (Go-to-Market).....	9
7. Estrutura operacional e equipe.....	10
8. Plano financeiro SaaS.....	11
9. Análise SWOT.....	13
10. Riscos e plano de mitigação.....	14
11. Roadmap e próximos passos (12–36 meses).....	15

1. Sumário executivo

HealthMatch é uma plataforma B2B (SaaS + marketplace gerenciado) que resolve uma das dores mais caras e silenciosas da saúde brasileira: preencher plantões e vagas com o profissional certo, credenciado e disponível, no tempo certo — hoje feito à mão, por WhatsApp, planilhas e telefonemas.

A plataforma combina um motor de matching (especialidade, CBO, situação de credenciamento, histórico de comparecimento e conflito de agenda), um agente de IA conversacional que aborda e negocia plantões via WhatsApp, e um back-office financeiro de intermediação (recebíveis do cliente, pagáveis ao profissional e margem da plataforma) — com trilha de auditoria e gestão de documentos.

Diferencial de entrada (wedge): o investidor-âncora é uma grande cooperativa de saúde do Ceará com 55 mil cooperados, que será simultaneamente (a) investidor estratégico, (b) primeiro cliente-âncora e (c) base massiva de oferta de profissionais. Isso elimina o problema do “ovo e galinha” de marketplaces: o HealthMatch nasce com liquidez de oferta e demanda no dia 1, com CAC de profissionais próximo de zero.

Item	Resumo
Modelo	Híbrido: assinatura SaaS (MRR) + fee de intermediação (take-rate sobre GMV de plantões)
Mercado (TAM Brasil)	◆ ~R\$ 15–20 bi/ano em GMV de plantões/escalas de saúde (estimativa bottom-up)
Beachhead	Cooperativas de saúde do Ceará/Nordeste → hospitais privados → setor público
Status do produto	Funcionalmente completo e testado internamente; pronto para o primeiro piloto
Ask (pre-seed)	R\$ 1,5 mi para ~20 meses de runway até o break-even operacional
Projeção realista	Receita líquida Ano 1 ~R\$ 1,1 mi → Ano 3 ~R\$ 16,5 mi; break-even ~mês 20–22
Time	Fundador solo (bootstrap); a rodada financia eng, CS/Ops e comercial

A tese: o staffing de saúde tech-enabled está validado globalmente (Nomad Health, Trusted Health, Medely nos EUA; Patchwork e Locum’s Nest no Reino Unido captaram centenas de milhões de dólares). No Brasil, o setor é gigante e ainda artesanal. O HealthMatch ataca esse mercado com um canal de distribuição privilegiado (a rede de cooperativas de saúde) e um produto pronto.

2. Descrição da plataforma

Missão: garantir que toda unidade de saúde tenha o profissional certo no plantão certo — com agilidade, conformidade e custo justo.

Visão: ser a camada de inteligência operacional do trabalho em saúde no Brasil — o “sistema operacional” que conecta profissionais, unidades, cooperativas e o poder público.

Proposta de valor

Para quem	Dor hoje	O que o HealthMatch entrega
Cooperativas / intermediadoras	Escala manual, WhatsApp, plantão descoberto, baixa visibilidade financeira	Preenchimento automatizado, IA que negocia plantões 24/7, painel de margem em tempo real
Hospitais / redes privadas	Plantões descobertos, dependência de poucos plantonistas, credenciamento manual	Banco de plantonistas qualificados, matching com checagem de credencial e conflito de agenda
Setor público (SUS / UPAs)	Dificuldade de cobertura, controle de presença, conformidade	Gestão de escala com auditoria, controle de comparecimento e rastreabilidade
Profissionais de saúde	Plantões via grupos informais, atrasos de pagamento, burocracia	Ofertas compatíveis com o perfil via WhatsApp e transparência de pagamento

Capacidades já existentes no produto: cadastro regulatório-aware (conselhos CRM/COREN/CREFITO, CBO, RQE, especialidades); matching com detecção de conflito de agenda e no-show; pipeline de vagas; candidaturas → alocações → escala com controle de presença; mensageria omnichannel (WhatsApp/SMS/e-mail) com agente de IA e handoff humano; financeiro de intermediação com margem; auditoria completa; RBAC; e white-label.

3. Análise de mercado

3.1 Contexto

O Brasil tem ~562 mil médicos ativos (CFM, 2024) e mais de 2,5 milhões de profissionais de saúde no total. A demanda por plantões é estrutural e crescente: envelhecimento populacional, expansão de UPAs/UBS, judicialização da saúde e déficit crônico de cobertura fora dos grandes centros. O preenchimento de plantões é, hoje, majoritariamente manual — grupos de WhatsApp, planilhas, agências locais e cooperativas com pouca tecnologia.

3.2 TAM / SAM / SOM (bottom-up)

♦ Metodologia: $GMV \text{ de plantões} = n^{\circ} \text{ de plantões/ano} \times \text{ticket médio}$ (assumido R\$ 1.300/plantão de 12h; Nordeste tende a ser menor que SP). A receita endereçável é uma fração do GMV (take-rate + SaaS).

Camada	Definição	GMV/ano	Receita endereçável (≈10%)
TAM	Todo o GMV de plantões/escalas de saúde no Brasil	♦ R\$ 15–20 bi	♦ R\$ 1,5–2,0 bi
SAM	Nordeste + cooperativas/hospitais privados/público	♦ R\$ 3–4 bi	♦ R\$ 300–450 mi
SOM (3–5 anos)	CE + cooperativas adjacentes do NE capturáveis	♦ R\$ 150–300 mi	♦ R\$ 15–30 mi

O SOM converge com a projeção financeira (Ano 3 realista ~R\$ 16,5 mi de receita líquida), mantendo o plano internamente consistente.

3.3 Tendências favoráveis

- Digitalização tardia da saúde operacional — a “última milha” (RH/escala) ainda é manual.
- Maturação do WhatsApp Business + IA generativa: automação de recrutamento conversacional a custo marginal baixíssimo.
- Pressão por eficiência e conformidade no setor público (controle de presença, prestação de contas).
- Modelo validado lá fora: Nomad Health, Trusted Health, Medely, ShiftMed (EUA); Patchwork, Locum’s Nest (Reino Unido).

3.4 Concorrência

Categoria	Quem é	Força	Fraqueza (oportunidade)
Status quo informal (concorrente #1)	WhatsApp, planilhas, telefonemas, “donos de escala”	Custo zero, já existe	Não escala, sem auditoria, sem matching
Agências/cooperativas tradicionais	Intermediadoras regionais, cooperativas médicas	Relacionamento, base de médicos	Pouca tecnologia, margens opacas
Software hospitalar (HIS)	Tasy/MV, Soul MV, ProDoctor	Implantados em hospitais	Sem foco em matching, IA e plantão
Gestão de clínicas / agenda	iClinic, Feegow, Docplanner	Base instalada	Foco em agenda clínica, não em escala
Marketplaces de saúde adjacentes	Conexa, Docway (telemedicina)	Tração digital	Não atacam escala/plantão

Categoria	Quem é	Força	Fraqueza (oportunidade)
Comps internacionais (validação)	Nomad, Trusted, Medely, Patchwork	Provam o modelo e o tamanho	Não operam no Brasil

Insight competitivo: o concorrente a vencer não é outro software — é o processo manual + agências locais. O HealthMatch ganha por ser ~10x mais rápido e barato que a operação manual, com conformidade e dados que o status quo não oferece, entrando por um canal que ninguém mais tem (a rede de cooperativas).

4. Público-alvo e personas

ICP recomendado (beachhead): começar dentro da cooperativa-âncora como design partner e primeiro cliente, usando seus 55 mil cooperados como oferta. Provar o modelo em Fortaleza, replicar para outras cooperativas do Nordeste, depois hospitais/redes privadas e, por fim, o setor público (UPAs/UBS).

Por que esse beachhead e não “hospitais” ou “público” direto: a cooperativa entrega liquidez dos dois lados no dia 1 (demanda + oferta) e um campeão interno com capital. Hospitais privados têm venda consultiva mais longa; o setor público exige licitação e ciclos longos — ambos são expansão, não entrada.

Personas

1. Coordenador(a) de escala da cooperativa (comprador/usuário-chave): vive apagando incêndio de plantão descoberto. Ganha automação e previsibilidade.
2. Diretor(a) financeiro/operações (decisor econômico): quer visibilidade de margem, redução de custo operacional e conformidade.
3. Médico/profissional cooperado (oferta): quer ofertas relevantes, sem burocracia e com pagamento transparente, pelo WhatsApp.
4. Gestor público/OSS de saúde (expansão): precisa cobrir UPAs/UBS com rastreabilidade para prestação de contas.

5. Produto e funcionalidades

Stack técnica: Backend NestJS + Prisma + PostgreSQL; Frontend Next.js (App Router) + Tailwind; IA via Anthropic (modelo Haiku para custo marginal baixo); mensageria via Twilio/WhatsApp/Meta/Zenvia; auth por cookie httpOnly; deploy em Docker. Arquitetura modular (~20 módulos) e API REST padronizada.

Módulos funcionais (implementados e testados — 32/32 testes de API, 14/14 de regras de negócio)

Módulo	O que faz
Matching	Pontua profissional x vaga (LOW/MEDIUM/HIGH), detecta conflito de agenda e elegibilidade, lista razões
Vagas & Contratos	Pipeline completo de plantão (avulso, recorrente, cobertura, mensal, pool de reserva)
Candidaturas → Alocações → Escala	Aprovação gera alocação; controle de presença/ausência/atraso
IA conversacional	Aborda e negocia plantões via WhatsApp, com tool calls e handoff humano para ações críticas
Financeiro	Recebíveis (cliente/órgão público), pagáveis (profissional), taxa de plataforma e margem
Credenciamento	Conselhos, CBO, RQE, especialidades, documentos com validade e revisão
Auditoria & RBAC	Trilha de toda mutação; perfis Admin/Manager/Operator/Viewer
White-label	Branding por cliente (essencial para vender a cooperativas com marca própria)

Maturidade: MVP construído e testado internamente, pronto para o primeiro piloto. Lacunas para escala (no roadmap): multi-tenancy robusto, billing automatizado (gateway/split), observabilidade, testes de carga e ativação plena do agente de IA.

6. Estratégia de marketing e vendas (Go-to-Market)

Fase 0 — Âncora (mês 0–6): fechar a cooperativa como investidor + cliente-âncora. Piloto em 1–2 unidades/especialidades, provando redução de tempo de preenchimento e de plantões descobertos. O case da âncora vira a principal peça de venda (co-marketing).

Fase 1 — Densidade regional (mês 6–18): expandir dentro da âncora e abordar outras cooperativas de saúde do Nordeste. Canal: venda direta consultiva (founder-led → 1º comercial), indicação da âncora e eventos do setor cooperativista.

Fase 2 — Novos segmentos (mês 18–36): hospitais e redes privadas do NE; piloto no setor público (UPAs/UBS via OSS); início de motor de inbound (conteúdo, SEO, indicações).

Canais de aquisição e CAC esperado

- Indicação/rede de cooperativas (CAC mais baixo) — principal motor.
- Venda direta consultiva (founder-led → SDR/closer).
- Marketing de conteúdo + eventos setoriais (médio prazo).
- ♦ Aquisição de profissionais (oferta): CAC ≈ R\$ 0 na âncora (55 mil cooperados pré-existent) — vantagem competitiva central.

7. Estrutura operacional e equipe

Hoje: fundador solo (bootstrap), produto construído. A rodada financia o time mínimo viável para operar e escalar.

Plano de contratação (uso da rodada)

Fase	Contratações	Racional
Imediato (mês 0–3)	1 Eng. full-stack sênior · 1 Customer Success/Ops	Hardening (multi-tenancy, billing) + onboarding da âncora e liquidez do marketplace
Mês 3–9	+1 Eng. · 1 Comercial (founder-led → closer)	Sustentar a âncora e abrir novas cooperativas
Mês 9–18	+1 Eng./Dados · +1 CS · suporte	Escala de IA/matching e múltiplos clientes
Contínuo (PJ/fracionado)	Design, Financeiro/Contábil, Jurídico/Compliance	Custo variável até justificar CLT

Estrutura jurídica/operacional: PJ enxuta, contabilidade terceirizada, jurídico/LGPD e compliance regulatório (dados de saúde) como prioridade desde o início. O founder acumula CEO + Produto na fase pre-seed.

8. Plano financeiro SaaS

◆ *Premissas-base (a validar no piloto): ticket médio por plantão R\$ 1.300; take-rate 5% (cons.) / 7% (real.) / 8% (otim.); ARPA SaaS ~R\$ 4.000/conta/mês; margem bruta blended 62%/68%/72% (líquida de meios de pagamento ~1,8% do GMV, WhatsApp ~R\$0,30/conversa e infra/IA); encargos trabalhistas ≈ 1,75× salário bruto.*

8.1 Drivers de volume (cenário realista)

Driver	Ano 1	Ano 2	Ano 3
Plantões intermediados (média/mês)	800	4.500	12.000
Plantões/ano	9.600	54.000	144.000
GMV/ano	R\$ 12,5 mi	R\$ 70,2 mi	R\$ 187,2 mi
Contas SaaS pagantes (saída do ano)	~10	~25	~55
MRR (saída do ano)	R\$ 35 mil	R\$ 150 mil	R\$ 420 mil

8.2 Receita — 3 cenários (receita líquida = take-rate + SaaS)

Cenário	Ano 1	Ano 2	Ano 3
Conservador	R\$ 0,43 mi	R\$ 2,26 mi	R\$ 6,38 mi
Realista	R\$ 1,09 mi	R\$ 5,99 mi	R\$ 16,5 mi
Otimista	R\$ 1,98 mi	R\$ 11,9 mi	R\$ 33,3 mi
GMV (Ano 3)	—	—	R\$ 187,2 mi

8.3 DRE resumida (cenário realista, R\$ mil)

Linha	Ano 1	Ano 2	Ano 3
Receita líquida	1.090	5.990	16.500
(-) COGS	(350)	(1.917)	(5.280)
Lucro bruto (≈68%)	740	4.073	11.220
Pessoal	(1.100)	(2.400)	(4.800)
Marketing & Vendas	(150)	(600)	(1.800)
Infra / ferramentas	(120)	(300)	(700)
G&A / jurídico / contábil	(120)	(300)	(700)
Opex total	(1.490)	(3.600)	(8.000)
EBITDA	(750)	+473	+3.220
Margem EBITDA	-69%	+8%	+20%

Break-even operacional (realista): ~mês 20–22 (durante o Ano 2). Conservador: ~mês 30+ (pode exigir ponte). Otimista: ~mês 14–16.

8.4 Métricas-chave SaaS (visão SaaS-only, conservadora)

◆ *Reporto a visão SaaS-only para ser defensável em pré-lançamento. A economia blended (SaaS + take-rate por cliente) é materialmente superior, mas limitada por liquidez, não por CAC.*

Métrica	Valor	Benchmark BR	Leitura
ARPA	R\$ 4.000/mês	—	Mix institucional
CAC (conta institucional)	R\$ 15.000	—	Venda consultiva B2B saúde
Churn anual (logo)	12%	10–15% bom	Alto switching cost

Métrica	Valor	Benchmark BR	Leitura
LTV (36m capado)	~R\$ 115 mil	—	Conservador (sem take)
LTV / CAC	~7,7×	>3 saudável	Forte; sobe no blended
Payback de CAC	~4,7 meses	<12m saudável	Excelente
CAC de profissionais	≈ R\$ 0 na âncora	—	Vantagem estrutural

8.5 Necessidade de investimento (o “ask”)

Captação pre-seed: R\$ 1,5 milhão para ~20 meses de runway, cruzando o vale de burn do Ano 1 (~R\$ 750 mil) com folga até o break-even.

Destino	%	Valor	Para quê
Produto & Engenharia	55%	R\$ 825 mil	Eng, multi-tenancy, billing/split, IA em produção
GTM (Vendas & Marketing)	18%	R\$ 270 mil	CS/Ops, comercial, co-marketing
Infra & COGS iniciais	10%	R\$ 150 mil	Cloud, WhatsApp, meios de pagamento
Jurídico/Compliance/LGPD	9%	R\$ 135 mil	Dados de saúde, contratos, IP
Reserva/contingência	8%	R\$ 120 mil	Buffer

Recomendação estratégica: estruturar a rodada com a cooperativa-âncora como investidora estratégica (“smart money”) — capital + primeiro contrato + oferta de 55 mil profissionais + porta para outras cooperativas. Idealmente um SAFE / nota conversível com teto (sugiro discutir a faixa de R\$ 6–10 mi) e desconto, evitando travar valuation cedo.

9. Análise SWOT

Forças	Fraquezas
• Produto construído e testado, pronto para piloto • Canal de distribuição único (rede de cooperativas) • Liquidez de oferta no dia 1 (55k cooperados) • IA + matching + financeiro num só lugar • CAC de oferta ≈ 0	• Fundador solo; sem time formado • Sem receita/tração comercial ainda • Dependência inicial de um único cliente-âncora • Multi-tenancy/billing ainda a construir • Produto ainda sem validação com clientes reais
Oportunidades	Ameaças
• Mercado enorme e manual (R\$ bi em GMV) • Expansão para o setor público (SUS/UPAs) • Sistema cooperativista nacional como esteira • IA reduz custo operacional drasticamente	• Cooperativa/cliente decidir construir in-house • Mudança regulatória (CLT $\times$ PJ, LGPD) • Players internacionais entrarem no Brasil • Concentração: perder a âncora seria crítico

10. Riscos e plano de mitigação

Risco	Prob./Impacto	Mitigação
Concentração na âncora	Médio/Alto	Usar o piloto para abrir 2–3 cooperativas no Ano 1; contrato plurianual com a âncora
Product-market fit ainda não comprovado	Médio/Alto	Piloto rápido com a âncora, com métricas de sucesso definidas (tempo de preenchimento, % de plantões descobertos)
Regulatório/trabalhista (PJ × CLT)	Médio/Alto	Jurídico especializado; posicionar como ferramenta de gestão da cooperativa, que detém o vínculo
LGPD / dados sensíveis de saúde	Médio/Alto	Compliance desde o início; criptografia, RBAC, DPO terceirizado
Meios de pagamento erodirem o take	Médio/Médio	Negociar split/escrow; opção “track-only” reduz COGS
Execução com time pequeno	Médio/Médio	Contratações-chave logo na rodada; founder foca em produto + âncora
Adoção pelos profissionais (oferta)	Baixo/Médio	IA via WhatsApp reduz fricção; âncora já tem relacionamento com cooperados

11. Roadmap e próximos passos (12–36 meses)

0–6 meses — Fundação & Âncora

- Fechar rodada pre-seed (com a cooperativa como investidora estratégica).
- Contratar Eng. sênior + CS/Ops. Blindar IP/LGPD.
- Hardening: multi-tenancy + billing/split + IA em produção.
- Piloto na âncora → métricas: tempo de preenchimento, % plantões descobertos, NPS do coordenador.

6–18 meses — Densidade regional

- Expandir dentro da âncora; abrir 2–3 cooperativas do NE.
- 1º comercial; co-marketing do case.
- Meta: MRR ~R\$ 150 mil e GMV ~R\$ 70 mi/ano (realista) → break-even ~mês 20–22.

18–36 meses — Expansão de segmento

- Hospitais/redes privadas do NE; piloto no setor público (UPAs/UBS).
- Motor de inbound (conteúdo/SEO) e indicações.
- Preparar rodada seed (com tração) para expansão nacional via sistema cooperativista.
- Meta: receita líquida ~R\$ 16,5 mi e EBITDA positivo (~20%).

Premissas críticas a validar no piloto

5. Ticket médio do plantão e take-rate aceito pela cooperativa (♦ R\$ 1.300 / 7%).
6. Volume real de plantões que migram para a plataforma.
7. Disposição da âncora a pagar SaaS e fee (modelo híbrido) — ou se concentra em um.
8. Custo efetivo de meios de pagamento (define operar o fluxo financeiro ou só “track-only”).
9. Churn e expansão reais entre cooperativas.